

Teams Boumzebra 1

(0:42 - 1:32)

Bonjour, faites signe si vous voyez l'écran et si le son est bien transmis. Très bien, donc nous allons passer ensemble environ une heure. Pendant cette heure, il n'y aura pas de cours classique.

(1:32 - 1:55)

Du moment que vous avez déjà le cours sonorisé, on ne va pas se répéter, mais je suis là pour répondre à vos questions. Donc le premier cours qu'on va avoir ensemble est sur les prothèses valvulaires cardiaques. Donc voilà, si vous avez des questions ou des choses qui ne sont pas claires sur ce cours-là, allez-y.

(1:55 - 2:11)

Sinon, je vais probablement m'engager un peu dans la discussion avec vous. Je suis à l'écoute, soit écrivez, soit... Est-ce qu'ils ont la main pour l'écran, pour le micro? Ils ont la main? Sinon, vous pouvez parler directement. OK.

(2:28 - 2:36)

Est-ce que ce cours est sur la plateforme? En principe, oui. Sinon, on le mettra sur la plateforme. Donc on va changer.

(2:38 - 2:50)

On mettra le cours sur la plateforme. D'accord. On va choisir un autre.

(2:55 - 3:21)

Voilà. Je pense que celui-là est sur la plateforme. Les varices des membres inférieurs, je pense qu'il est sur la plateforme.

(4:44 - 4:58)

N'hésitez pas à poser des questions. Je suis là. On peut aller de la définition vers les... Ce n'est pas grave si vous ne respectez pas l'ordre du cours.

(4:59 - 5:24)

N'importe quelle question est la bienvenue. Vous pouvez parler si vous avez du mal à écrire. Il y a une question.

(5:24 - 6:06)

Pourquoi le sexe féminin prédispose au développement des varices? Alors, comme vous le savez, la grossesse gêne le retour veineux. Le fait que pendant la grossesse, il y ait une compression pendant quelques mois du retour veineux, ça engendre une prédisposition spécifique chez la femme. À côté de cela, j'estime qu'il y a des hypothèses d'ordre hormonaux qui peuvent également prédisposer la femme aux varices.

(6:06 - 6:54)

Mais ce qui est sûr, c'est que la prévalence des varices est plus importante pendant la grossesse du fait de la compression des veines iliaques et du retour veineux systémique. Très bien. Alors, dans l'attente d'une question sur cette diapositive là de prévalence, il faut retenir cette prévalence parce que c'est important.

(6:55 - 7:33)

Ce qui fait que les varices constituent un problème de santé publique. C'est assez fréquent dans la population générale. OK, d'autres questions? Vous êtes 48 à me suivre.

(7:33 - 7:53)

Sûrement, il y aura des questions. Allez-y. N'hésitez pas et je vous ai dit qu'il ne faut pas respecter l'ordre pour poser la question au niveau du traitement, au niveau de la partie réservée à la clinique ou aux examens par clinique.

(7:53 - 8:29)

Donc, ce n'est pas grave si vous ne respectez pas l'ordre. S'il vous plaît, à quel moment est-ce qu'on décide de traiter chirurgicalement les varices? Alors, le traitement, il y a bien sûr, il y a les règles chirurgicales qui sont toujours de mise pour le traitement. Donc, il y a l'option chirurgicale qui est le traitement de référence.

(8:29 - 9:03)

Il y a également l'option intervention. Donc, les mesures d'hygiène, comme vous voyez ici, on encourage la marche sur l'élévation des membres qui va aider le retour veineux et donc soulager le symptôme. La contention élastique, ça permet de comprimer les veines, donc de favoriser nos retours, éviter ou limiter la station debout et puis, il faut éviter l'œdème.

(9:03 - 9:27)

Donc, ça, c'est des règles d'hygiène qu'il faut toujours prescrire. Maintenant, mis à part ça, les traitements médicaux, pas les vétoniques, n'ont pas franchement prouvé d'efficacité. Mais bon, concernant la sclérothérapie, il reste réservé pour les veines qui ne sont pas très dilatées.

(9:27 - 9:58)

Par contre, le traitement chirurgical est indiqué, comme vous voyez ici, quand la crosse est incontinente, quand le tronc de la grande olapis saphée est incontinent et quand la veine est très dilatée. Donc, il faut associer deux éléments. L'incontinence des valvules, que ce soit au niveau de la crosse ou au niveau du tronc, associé à cela des veines qui sont dilatées.

(9:58 - 10:31)

À ce moment-là, on propose un traitement chirurgical. Maintenant, quand les valvules sont incontinents, alors que la veine n'est pas très dilatée, ce type de varice peut être traité par des techniques interventionnelles, telles que la radiofréquence ou le laser. Quand les veines sont très dilatées, l'ablation chirurgicale semble être mieux.

(10:32 - 10:57)

Voilà, c'était la question quant à cela. Les éléments où l'insuffisance veineuse fonctionne. L'insuffisance veineuse fonctionnelle est un retour veineux dans le sens inverse de la circulation normale au niveau des veines superficielles.

(10:58 - 11:14)

Il est dit fonctionnel parce qu'il n'y a pas d'atteinte des valvules. Les valvules ne sont pas malades. Il y a une dilatation des veines, mais les valvules ne sont pas malades.

(11:15 - 11:34)

Je vais probablement vous expliquer cela. Si vous voyez ici, par exemple, les valvules sont malades. Il y a une atteinte organique des valvules.

(11:34 - 11:43)

Là, il n'y a pas d'atteinte organique des valvules. C'est plutôt une dilatation de la veine. C'est une dilatation secondaire.

(11:44 - 11:54)

Comme je l'ai dit, il y a un problème de retour, une compression. Mais les valvules, elles n'étaient pas malades. À ce moment-là, on parle d'insuffisance veineuse, plutôt d'ordre fonctionnel.

(11:54 - 12:21)

Il n'est pas organique. Voilà, d'autres questions. Les manœuvres fonctionnelles, c'est des manœuvres qu'on réalise pour confirmer l'existence d'une incontinence veineuse.

(12:21 - 12:37)

Ces manœuvres fonctionnelles ne sont pas actuellement très utilisées. Pourquoi? Parce qu'elles sont supplémentées par l'existence des codoplaies. Voilà ces manœuvres fonctionnelles.

(12:38 - 13:08)

Vous voyez ici, si le membre est allongé, le patient est allongé, on mettra des garrons et on mettra le patient debout. Quand on enlève les garrons, on va voir s'il y a un remplissage des veines de haut en bas, comme ici. Quand on a enlevé le garron supérieur au niveau de la crosse, il y a un retour veineux de haut vers le bas.

(13:09 - 13:37)

Donc ça témoigne d'une incontinence ostiale de la crosse de la grande sapine. Un remplissage de haut en bas témoigne d'une incontinence veineuse superficielle au niveau de la crosse de la grande sapine. Mais en pratique clinique actuellement, ces manœuvres, on peut également les utiliser pour détecter une perforante.

(13:38 - 13:52)

C'est-à-dire qu'on va mettre deux garrons par exemple ici. Le patient va se mettre debout. Si la veine entre les deux garrons se remplit, ça veut dire qu'il y a une incontinence d'une perforante qui va permettre le remplissage de ce segment veineux.

(13:52 - 14:42)

Mais en pratique clinique, elles ne sont pas utilisées actuellement. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'échodoplaire veineux qui a surmonté les intérêts de ce que peuvent apporter les manœuvres fonctionnelles. S'il vous plaît, monsieur Ibrahim Afaï, vous parlez, sinon éteignez votre micro.

(14:43 - 15:34)

Merci. Bien. Pas d'autres questions concernant les varices des membres inférieurs ? Quel est le mécanisme des varices ? Par quel mécanisme les varices peuvent se compliquer l'ulcère varicoële ? Par quel mécanisme ? Alors, les varices vont engendrer une compression du fait de l'œdème.

(15:35 - 16:24)

Ils vont engendrer une compression avec compression de la circulation sanguine. Donc, les varices avec la stase veineuse vont engendrer un œdème et l'œdème va comprimer les tissus succutanés ce qui va engendrer une ischémie et avec l'ischémie chronique va arriver la nécrose et donc la formation de l'ulcère. Donc, c'est l'œdème avec la compression des capillaires et la

création d'une ischémie progressivement jusqu'à la nécrose cutanée.

(16:24 - 16:58)

Parfois, il y a une rupture de varices également superficielle et la rupture des varices peut également, s'il est maltraité, se voir lors de l'évolution terminale des varices. C'est un mécanisme ischémique. C'est une compression par l'œdème et l'arrêt de la circulation ou de la micro-circulation au niveau de la zone de l'ulcère.

(16:58 - 17:38)

C'est pour cela que parmi les premiers choses à faire il faut enlever cette stase veineuse par la bande élastique il faut enlever l'œdème par la compression externe. L'éveinage veut dire l'ablation d'un paquet de veines qui n'est pas systématisé. Quand on enlève un paquet variqueux c'est une veine qui est malade mais qui n'est pas rectiligne on appelle ça éveinage.

(17:38 - 19:15)

C'est l'ablation d'une veine. Est-ce qu'on peut prescrire des anticoagulants pour les varices ? Je n'ai pas cité dans le traitement les anticoagulants pour les varices. Maintenant, si les varices sont compliqués d'une thrombose veineuse à ce moment-là on peut prescrire des anticoagulants.

(19:15 - 19:32)

Pour les varices non compliqués, non. Il n'y a pas d'indication aux anticoagulants. Alors, pour Jelly Noran pas d'indication d'anticoagulants pour les varices non compliqués.

(19:33 - 1:04:15)

Quand les varices sont compliqués par une thrombose veineuse à ce moment-là on prescrit des anticoagulants. Qu'est-ce que ça veut dire un stripping ? Un stripping ça veut dire enlever le stripping je vais vous montrer ça on introduit dans la veine un cathéter une tige métallique ou un fil à l'intérieur de la veine on va fixer la veine à cette tige qu'on appelle le stripper et on va tirer généralement au niveau de la malliole ou à partir du segment qui est là c'est une incontinence du segment plurale au niveau de la cuisse donc on a abordé la veine au niveau c'est plus clair on a abordé la veine au niveau de la malliole on a introduit un fil qu'on a retiré ici à la fin on va attacher ça à la veine et on va tirer sur le fil ou sur le stripper on va enlever on va tirer on va arracher la veine qui va s'invaginer voilà très bien est-ce que la rupture du varice reste un phénomène rare ou pas en pratique clinique ce n'est pas très fréquent il est rare que les malades construisent un stade de rupture mais sachez que ça existe parfois aux urgences vous allez voir des malades qui arrivent avec un saignement au niveau de la malliole lié à une rupture du varice je n'ai pas de statistiques à vous donner mais c'est vrai en pratique clinique ce n'est pas un phénomène très fréquent alors pour Meroa Mskine je vous renvoie vers les il faut quand même avant la session vous devez lire un peu les diapos parce que vous avez ici des éléments de réponse pour cette

question voilà la réponse le réseau profond c'est celui qui draine la majeure partie du sang veineux du membre inférieur le réseau profond draine 90% de la circulation sanguine par contre le réseau superficiel le réseau superficiel s'il vous plaît donc par contre le réseau superficiel quand on dit varice on parle de réseau superficiel qui ne draine que 10% du sang veineux donc en fait quand on enlève une veine superficielle ça ne représente pas plus de 10% quand je dis réseau superficiel c'est une veine saphène les deux drainent 10% donc si on enlève la veine par exemple la grande saphène on va enlever 7% du drainage veineux il est rapidement compensé par le drainage vers le système veineux profond donc il n'y aura pas de problème très bien alors une autre question alors je pense que j'ai déjà répondu à cette question concernant le traitement le traitement vénotonique ne peut être conçu qu'au début de la maladie c'est à dire quand les veines ne sont pas très dilatées et quand la musculature des veines est encore je dirais en bon état et qu'il peut répondre à un traitement vénotonique une fois les veines très dilatées le traitement vénotonique ne sert plus à rien donc vénotonique mais quand au début de la maladie si vous examinez un malade vous trouvez des veines des cordons veineux de 15-20 mm donner des vénotoniques ne sert pratiquement à rien donc vénotonique c'est au début de la maladie quand les veines ne sont pas très dilatées d'autres questions alors est-ce que le traitement chirurgical permet de prévenir les récurrences non, le traitement chirurgical enlève les veines malades pour prévenir les récurrences il faut bien respecter la règle d'hygiène c'est à dire il faut mettre une contention élastique il faut respecter la marche il faut probablement un reclassement professionnel si c'est un métier où on est tout le temps debout donc c'est ça qui va prévenir la récurrence mais le traitement chirurgical non le traitement chirurgical va enlever la veine de malade pour prévenir la récurrence il faut respecter les règles d'hygiène que j'ai citées dans le traitement très bien alors pour Mohamed Belrit je n'ai pas compris la question est-ce que la position du patient lors d'un examen clinique influence les symptômes je n'ai pas compris la question peux-tu la reformuler dans l'attente de la reformulation de la question de Mohamed Belrit pour examiner un malade pour voir les varices il faut que le malade soit en position debout d'accord pour voir les veines qui sont dilatées pour voir dans quel territoire est-ce que c'est le territoire de la grande safel ou le territoire de la petite safel est-ce que c'est des veines qui sont systématisées ou des veines non systématisées est-ce que c'est des veines réticulées ou des varices de grande taille est-ce qu'il y a une relation entre les symptômes et la position du patient lors de l'examen clinique aucune relation les symptômes sont liés à l'incontinence veineuse pas à la position du malade lors de l'examen clinique professeur je voulais dire est-ce qu'il y a une position qui pourrait améliorer la symptomatologie si par exemple le patient il est debout ou bien il est couché est-ce qu'il y a une différence sur le plan de symptomatologie alors la question plutôt quelle est la position qui soulage le patient oui voilà la réponse elle est là je l'ai projeté tout à l'heure c'est la position couché la surélévation des membres donc c'est une position couché avec une surélévation des membres donc généralement les malades généralement ils découvrent ça tout seul quand ils rentrent le soir ils s'allongent puis ils vont mettre deux oreillers sous les jambes et puis avec cette position là ils sont soulagés rapidement donc c'est la position allongée avec surélévation des membres d'accord cette position qui soulage les symptômes alors bien sûr

ça d'une part d'autre part pour quelqu'un qui travaille toujours en position debout si on peut éviter la station debout pendant le travail ça permet de soulager les symptômes ainsi que bien sûr il faut proscrire les talons parce que je ne sais pas si on a fait un commentaire sur ça mais la pompe la pompe musculaire au niveau du pied est importante pour la chasse sanguine quand on met des talons on gêne le fonctionnement de la pompe musculaire au niveau du pied donc c'est pour cela qu'on proscrie les talons parce que ça gêne le début d'un bon drainage sanguin avec le talon on gêne le démarrage d'un bon drainage sanguin au niveau du pied c'est pour cela qu'on évite on dit toujours qu'il faut éviter le talon très bien d'autres questions vous voulez qu'on passe à un autre chapitre alors vous m'avez dit que ce cours là on va passer au cours concernant les prothèses vous m'avez dit que ce cours là n'existe pas sur la plateforme très bien alors voilà il nous reste 35 minutes on va le faire ensemble et puis si vous avez des questions on peut toujours la prochaine fois vous poser des questions concernant les prothèses valvulaires donc on va le faire tout de suite ensemble donc les prothèses valvulaires cardiaques qui est un chapitre intéressant que vous devez absolument lire pourquoi parce que c'est grâce aux prothèses valvulaires cardiaques qu'on a pu traiter les valvulopathies au rhumatisme chez les jeunes et les valvulopathies dégénératives chez l'adulte alors pourquoi ces prothèses parce que parfois on ne peut pas réparer parfois on ne peut pas réparer la valve donc quand la valve est en plastique la réparation de la valve est impossible donc les deux valves les plus souvent intéressées c'est la valve aortique et la valve mitrale sachez qu'il existe deux types de prothèses valvulaires cardiaques les valves mécaniques et les valves biologiques malgré le développement technologique sachez qu'il n'y a pas de prothèse parfaite donc jusqu'à maintenant on n'a pas de prothèse parfaite et on a toujours des problèmes avec ces prothèses d'où le risque de complications potentielles c'est la surveillance stricte des prothèses cardiaques qui garantit le bon fonctionnement donc il y a les prothèses mécaniques et puis on va voir les prothèses biologiques les prothèses mécaniques elles sont fabriquées à partir soit du plastique du plastique et du métal avec un nano de carbone pyrolytique plus trois éléments mobiles donc la structure des prothèses mécaniques on a de la matière plastique et du métal avec un nano donc il y a plusieurs catégories il y a les prothèses à billes qu'on n'utilise plus maintenant il y a les prothèses à disques oscillants et puis il y a les prothèses à ailettes donc retenez s'il vous plaît c'est les prothèses à ailettes qui sont les plus utilisées maintenant deuxième catégorie voilà la valve à billes il faut l'oublier, elle n'existe plus maintenant sur le marché la valve à disques elle est en voie de disparition la valve à double ailettes qui est actuellement utilisée alors pourquoi ces deux valves ont été abandonnées parce qu'elles sont hautement thrombogènes par opposition aux valves à double ailettes qui sont moyennement, faiblement thrombogènes vous m'entendez bien ? alors l'avantage des valves mécaniques c'est qu'elles durent toute la vie en dehors de complications on peut voir par opposition à la valve biologique la durée de vie de la valve mécanique c'est pendant toute la vie mais l'inconvénient de la valve mécanique c'est que le clignement du sang, comme on l'a dit, il est peu physiologique et on a un gradient transvalvulaire qui peut persister du fait vous voyez ici la valve mécanique comment elle est elle est en quelque sorte encombrante et obstruante donc elle obstruit un peu l'orifice donc on a toujours un petit gradient qui reste même après le

remplacement de la valve donc l'écoulement est peu physiologique avec persistance de gradient transvalvulaire le risque d'hémolyse le fait que le sang percute les élèbes de la valve un risque d'hémolyse et puis la thrombogénicité qui est élevée donc ça nécessite une anticoagulation avide par les antivitaminés le bruit de la prothèse qui est perçu par le patient parfois peut être dérangeant donc le bruit de la prothèse est également un inconvénient les prothèses biologiques il y en a trois types les hétérogreffes, l'homogreffe et l'auto greffe l'hétérogreffe il est fabriqué à base de la valve ou du porc, du porc ou du veau l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'anticoagulation avide mais l'inconvénient c'est que ces valves dégénèrent rapidement d'où la nécessité d'une réintervention donc en comparant la valve biologique et la valve mécanique la valve biologique a une durée de vie limitée et donc quand on implante une valve biologique on explique au patient que après une certaine période probablement vous aurez besoin d'une deuxième intervention chirurgicale voilà comment ça se présente la valve biologique, voilà un auto greffe sur lequel on va fixer la valve biologique du porc ou du veau ça c'était les hétérogreffes les homogreffes c'est des valves qui sont prélevées dans le cadre d'un prélèvement multi-organes, un sujet en état de mort cérébral prélèvement sur un cadavre après le décès dans les 24 heures l'avantage est plus physiologique que l'hétérogreffe parce qu'il n'y a pas d'armature il n'y a pas d'auto greffe donc c'est plus physiologique l'inconvénient c'est qu'il y a une pénurie de greffes de greffons et donc ce n'est pas toujours facile de trouver les homogreffes nous à Marrakech nous avons commencé à prélever nous avons prélevé je pense en total 6 homogreffes que nous avons déjà utilisés alors l'indication très classique étant l'endocardite aortique riche en gènes ou dans le rétablissement de continuité entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire ça reste les meilleures indications des homogreffes l'endocardite aortique riche en gènes et le rétablissement de la continuité entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire en cas de cas d'hépatite congénitale qui est avec un obstacle sur le ventricule droit alors les critères généraux de prélèvement comment on prélève ces homogreffes j'ai cité ici les critères le donneur doit répondre à un certain nombre de caractéristiques générales être jeune sans valvulopathie bien sûr sans pathologie auto-immunoméplasique sans maladie infectieuse et ne pas décéder à cause d'une septicémie ou d'une endocardite le prélèvement doit respecter les règles et les conditions de stérilité au bloc opératoire là il y a des détails techniques concernant la valve aortique comment on prélève la valve aortique et la valve mitrale sachez que quand on prélève des pièces de tissu sont mises en culture jusqu'à 6 semaines afin de vérifier l'absence de contamination donc quand on fait un prélèvement d'une homogreffe on va enlever une pièce de tissu en culture jusqu'à 6 semaines afin de vérifier l'absence de contamination lors du processus puis ces valves sont conservées selon deux techniques l'homogreffe fraîche on va la préserver dans un réfrigérateur donc la valve est stérilisée dans une solution d'antibiotiques donc la composition de cette solution est différente selon les laboratoires généralement il y a de la séphoxythine la polymyxine B et puis on va mettre cette valve dans ce liquide on va la conserver dans un milieu nutritif à base de sérum de fœtus de veau à 4°C donc on la mettra dans un réfrigérateur à 4°C les homogreffes créopréservés on va les mettre à la créopréservation à l'azote liquide et cette préservation peut rester plusieurs années donc les homogreffes fraîches

on les préserve pendant quelques mois généralement 3 mois par contre la créopréservation grâce à la baisse de la température va se permettre de préserver la valve pendant plusieurs années le troisième type de valve biologique c'est les homogreffes c'est qu'on va prélever la valve du patient lui-même qu'on va réimplanter au niveau d'un autre orifice c'est ce qu'on appelle l'intervention de Ross on va enlever la valve pulmonaire qu'on va implanter en position antérieure et donc on va mettre une homogreffe en position pulmonaire donc parfois on préfère utiliser la valve pulmonaire en position aortique parce que la valve aortique est très malade et remplacer la valve pulmonaire par une homogreffe ça s'appelle l'intervention de Ross et il est surtout indiqué chez l'enfant qui a une sténose de la valve aortique ou une maladie de la valve aortique et on ne peut pas mettre une valve mécanique parce que ça va arrêter la croissance de l'orifice aortique et vu le risque d'anticoagulation et d'ailleurs le meilleur indication c'est le remplacement de la valve aortique chez l'enfant voilà une comparaison entre les valves mécaniques et les valves biologiques quels sont les critères qu'on prend en considération pour les deux situations les prothèses mécaniques si le patient désire la prothèse mécanique c'est un point important à prendre en considération en cas d'absence de contre-indication aux anticoagulants quand même que le malade n'a pas de contre-indication pour l'âge quand le patient est âgé de moins de 60 ans il vaut mieux préférer une valve mécanique en position aortique que moins de 65 ans en position mitrale les patients à un risque de dégénérescence les patients jeunes vont attaquer les valves biologiques si la dégénérescence est plus élevée chez les jeunes par exemple chez les jeunes de moins de 40 ans avec hyperparathyroïdisme même s'ils souhaitent avoir une valve biologique on sait qu'il va dégénérer rapidement quand le patient est déjà sous anti-vitamine K il a une arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire il est déjà sous anti-vitamine K on va mettre une valve mécanique les prothèses biologiques là encore on fait attention au désir du patient si il y a une contre-indication aux anti-vitamine K on va préférer une valve biologique un patient de plus de 65 ans qui a besoin d'un remplacement d'une valve aortique c'est une valve biologique en position aortique et plus ou moins de 10 ans en position mitrale si on a par exemple une patiente de 30 ans mais qui désire encore avoir des grossesses de 40 ans à ce moment là il faut mettre une valve biologique pour éviter le traitement aux anticoagulants ou s'il y a d'autres comorbidités avec une espérance de vie limitée par exemple un patient de 50 ans et qui a par exemple un cancer métastatique avec une espérance de vie de moins de 10 ans c'est pas la peine de mettre une valve mécanique parce que l'espérance de vie est limitée du fait de sa maladie donc voilà ce tableau là qui résume un petit peu le choix des valves en fonction de l'âge donc là vous avez la valve aortique en haut et la valve mitrale en bas donc vous voyez que là par exemple pour la valve aortique à partir de 65 ans c'est du bioprothèse pour la valve mitrale c'est à partir de 70 ans pour moins de 60 ans c'est la valve mécanique moins de 65 ans c'est la valve mécanique mais entre les deux il y a toujours entre 65 et 70 ans pour la valve mitrale il y a toujours une zone grise c'est pareil entre 60 et 65 ans pour la valve aortique une zone grise et en haut il y a toujours une discussion de choix entre valve mécanique et valve biologique donc les valves cardiaques peuvent se compliquer et donc j'ai cité ici toutes les complications qu'on peut rencontrer si le traitement anticoagulant est mal suivi on peut avoir une thrombose de prothèse si le traitement

anticoagulant est excessif on peut avoir une excision hémorragique si on ne respecte pas les règles d'hygiène on peut avoir une endocardite infectieuse j'ai vu une question je vais répondre par la suite s'il n'y a pas de respect des règles d'hygiène on peut avoir une endocardite infectieuse il peut y avoir une désinsertion de la prothèse une dégénérescence de prothèse biologique ou une hémorragie l'hémorragie peut être liée à une fuite mitrale paraprothétique parfois il y a une fuite mitrale paraprothétique qui peut donner une liste des éléments figurés du sang alors là on a plus de détails sur ces complications la thrombose de valve c'est essentiellement les valves mécaniques la thrombose peut être totale quand la thrombose est totale c'est un tableau brutal dans un pays et vous avez les éléments diagnostiques la radio va montrer la radio va confirmer le diagnostic la radio cinéma qui va montrer l'absence de mobilité des ailettes l'ILR va être sous dosage c'est une maladie qui ne suit pas très bien il faut anticonvulser il faut hospitaliser rapidement mettre en route un traitement anticonvulsant une intervention en urgence quand l'obstruction n'est pas obstructive quand la thrombose n'est pas obstructive le patient peut être asymptomatique développer des accidents thromboemboliques on va trouver un gradient à l'échocardiographie une mobilité limitée à la radio cinéma la radio cinéma c'est la radioscopie soit au centre 4T ou la radio mobile c'est les rayons X on va mettre le patient sous rayon X continue pour voir la mobilité des ailettes c'est ça la radio cinéma il y a un sous dosage il faut optimiser le traitement médical surveiller le patient les accidents hémorragiques sont liés au sous-dosage au changement du régime alimentaire c'est extrêmement important il faut faire attention au régime alimentaire au transit un patient qui constipé risque d'être exposé aux accidents sous-dosage parce que l'antivitamine K sera réabsorbée par l'intestin il y a certains aliments qui interfèrent avec les AVK tels que tous les légumes de couleur verte qui vont diminuer l'efficacité des antivitamines K donc le changement du régime doit amener le médecin à donner des conseils il faut faire des dosages répétés pour éviter les accidents hémorragiques des dosages répétés de l'INR les accidents hémorragiques peuvent engager la pronostic vitale du patient le traitement de l'antivitamine K on peut neutraliser l'antivitamine K par l'injection intraveineuse de la vitamine K l'antidote de l'antivitamine K c'est la vitamine K les complications infectieuses au moment de l'endocardite elles sont plus fréquentes en position aortique et le diagnostic repose sur l'association d'une fièvre et d'un souffle les éléments diagnostiques le traitement de l'endocardite a été discuté dans le chapitre des endocardites traitées par les cardiologues le TT, le TO vont montrer des végétations le CT va être élevé, positif et l'hémoculture pour isoler le germe le type de germe dans l'endocardite précoce moins d'un an c'est le staphylocoque dans l'endocardite tardif plus d'un an c'est plutôt le staphylocoque et l'enterocoque le traitement repose sur le traitement antibiotique pendant 4 à 6 semaines la chirurgie est indiquée s'il y a une instabilité hémodynamique c'est une désinsertion de la prothèse c'est une persistance de l'infection si les végétations sont menaçantes c'est à dire si les végétations sont de grande taille qui sont très mobiles avec risque de détachement et de migration vers le cerveau la désinsertion de valves c'est fait suite à un lâchage de suture spontané ou septique le diagnostic repose sur la réapparition de la dyspléie, de l'anémie systolique ou diastolique selon la valve concernée parfois on met un tableau en dos à pied le TT va montrer une fuite paraprothétique le traitement

si la désinsertion est minime à ce compte d'une surveillance s'il est massif on va proposer la chirurgie les valves cardiaques ont besoin d'une surveillance, c'est suivi par la clinique 4 à 6 semaines après l'intervention, puis tous les 6 mois puis une fois par an l'éducation du patient quant à l'usage des anticoagulants et les règles d'hygiène à respecter il faut faire attention aux gestes invasifs quand on veut se faire soigner il faut toujours prévenir son médecin qu'on est porteur de valves cardiaques l'accord de porteur de prothèses la prophylaxie de l'endocardite chaque fois qu'on fait des gestes de soins dentaires de colonoscopie, de fibroscopie il faut dire au médecin qu'on est porteur quand on voit le patient on va lui demander s'il a de la fièvre s'il a des hémorragies par exemple s'il a des signes de congestion à l'auscultation on cherche le bruit d'ouverture fermeture des ailettes, s'il y a un souffle on cherche des signes d'insuffisance cardiaque la surveillance par la clinique se fait par un tp linéaire mensuel l'objectif est fait en 2005 dans la prothèse mitrale l'objectif thérapeutique est entre 3 et 4 il faut toujours demander une NFS par an un ECG, une radiothorax une fois par an le tt très fiable montre la dysfonction de prothèse le fonction montre qu'il est en gauche il va apprécier la fonction ventriculaire gauche et il détectera un dépanchement péricardique éventuel il faut toujours faire un bilan un arrêt stomatologique deux fois par an pour guetter l'infection ça a été rapide mais c'est au moins un aperçu rapide sur les valves cardiaques malgré tout le procès technique qui a concerné la fabrication et la production de ces prothèses cardiaques l'amélioration n'a pas pu arriver au stade d'avoir une prothèse exemplaire une prothèse sans faille donc la prothèse mécanique elle est bien sur le plan hémodynamique mais elle dure pendant toute la vie mais elle a besoin d'un traitement anticoagulant à vie donc avec tous les traitements anticoagulants la prothèse biologique est meilleure mais elle est rapidement attaquée par les anticorps de l'organisme et donc elle dégénère rapidement on a besoin de réopérer le malade il faut un suivi de toutes les manières je pense que vous devez retenir de ce cours un patient porteur d'une valve cardiaque a besoin d'un suivi rigoureux une bonne éducation des patients c'est à ce prix là qu'on va garantir un résultat excellent avec moins de complications il nous reste 10 minutes je vais répondre à quelques questions pourquoi on vise des valeurs il y a eu une question sur le seuil pourquoi c'est différent pour la mitrale et pour la diapositive alors pourquoi c'est différent entre la mitrale par exemple ici on dit que la prothèse mécanique pour la patient moins de 60 ans pour la mitrale moins de 65 ans c'est une question de d'hémodynamique et de risque de complications par exemple si on prend un patient âgé de plus de 65 ans et qui a besoin d'une valve on est en position aortique s'il a plus de 65 ans et qu'il a une valve biologique la valve biologique va tenir une dizaine d'années donc il va arriver à 75 ans l'espérance de vie en moyenne par exemple au Maroc ici c'est 73-75 ans donc plus de 65 ans une valve biologique il va vivre avec cette valve l'âge moyen des marocains s'il n'a pas d'autres malformations d'autres maladies associées alors s'il a moins de 60 ans si tu mets une valve biologique il va dégénérer rapidement pour la valve mitrale c'est pratiquement pareil maintenant pourquoi la différence en position aortique l'hémodynamique permet un bon lavage des ailettes et donc on peut mettre une valve biologique, une valve mécanique chez un patient en position aortique on n'aura pas beaucoup d'accidents aux antibiotiques américains c'est pour cela qu'on limite mettre une valve mécanique en position

aortique voilà j'espère que j'ai répondu à la question puis de la dégénérescence les valeurs différentes entre la prothèse mitrale et la prothèse aortique c'est une question de lavage de la valve en position aortique la valve mécanique est mieux lavée parce qu'il y a une différence de pression très importante entre le ventricule gauche et l'aorte et donc pendant l'éjection il y a un bon lavage des ailettes et donc le risque de thrombose de valve est faible, c'est pour cela que l'objectif d'un niénial est faible en position aortique par rapport à la position mitrale en position mitrale le gradient n'est pas important ou le lavage des ailettes n'est pas très bien fait c'est pour cela qu'on vise un niénial beaucoup plus important une anticorrosion plus efficace la dégénérescence de la valve biologique survient en moyenne au bout de combien de temps et comment reconnaître cliniquement sa dégénérescence ? en moyenne c'est 8 à 10 ans il y a des essais pour qu'on puisse atteindre 15 ans mais actuellement c'est 8 à 10 ans alors comment reconnaître cette dégénérescence ? c'est l'apparition de signes cliniques c'est l'apparition de la dysplie, du souffle et à l'échocardiographie on va trouver des signes directs les feuilles qui vont devenir épices et l'apparition d'un gradient c'est essentiellement l'apparition de la dysplie du souffle et l'apparition du gradient comment l'hyperthyroïdie favorise cette dégénérescence ? l'hyperthyroïdie est un problème de métabolisme calcique et le fait qu'il y a un problème de métabolisme calcique il va y avoir un dépôt de calcium au niveau des feuilles valvulaires et donc une dégénérescence plus rapide des valves biologiques voilà il y a encore d'autres questions concernant ce chapitre là des valves bien, est-ce qu'il y a d'autres questions ? s'il vous plaît bien, donc s'il n'y a pas de questions nous avons une connexion demain si vous avez d'autres questions concernant les valves on peut toujours les poser demain s'il vous plaît, essayez de réviser les cours que vous avez sur la plateforme notamment l'esquimie aiguë ou inférieure l'artériopathie, l'anivrisme, la correction et la dissection donc demain vous aurez également deux cours et préparez vos questions comme ça vous pourrez mieux de cette séance interactive merci et à la prochaine fois